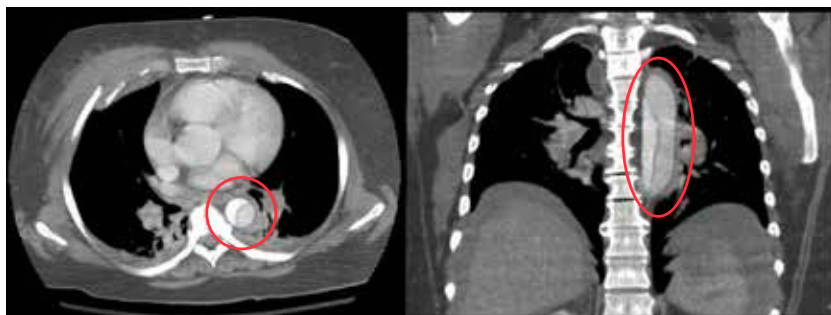




תמונה 10.5 הדמיית CT

הדיסקציה (קרע) של האאורטה

(מסומן בעיגול אדום) משתי זוויות שונות.

(מזכה: JasonRobertYoungMD, Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-rid=38278027>)

הטיפול בדיסקציה של האאורטה

בכל מקרה של דיסקציה יש לתמוך ב־ABC, לעשות אק"ג ולפנות בהקדם למיון. טיפול בכאב הוא חשוב מאוד, אך בדרך כלל פתולוגיה זו לא מגיבה לאנלגזיה, ויש להשתמש באופיאטים. בבית החולים יש לייצב את לחץ הדם. לאירועים של יתר לחץ דם בדיסקציה תרופות הבחירה הן חוסמי בטא (β blockers).

טיפול דפיניטיבי בדיסקציה של האאורטה יכול להיות תרופות, התקנת סטנט ויכול להיות כירורגי, החלפת קטע של אאורטה בשרוול דם. בדיסקציות באאורטה העולה או במקרים שבהם מצבו ההמודינמי של המטופל אינו יציב - טיפול הבחירה הוא ניתוחי. בדיסקציות באאורטה היורדת טיפול הבחירה הוא תרופתי, אלא אם כן הדיסקציה מסתבכת ומופיע קרע (rupture).

הלם (Shock)

הלם מוגדר כירידה בזילוח הדם ובאספקת החמצן לרקמות הגוף. יש גורמים רבים להלם, ביטויים קליניים שונים בין מטופלים, דרגות חומרה שונות וטיפולים שונים. למעשה זהו אוסף גדול של הפרעות פיזיולוגיות. הלם יכול להשפיע מערכתית (על הגוף כולו) או מקומית (ברקמה ספציפית). המגוון הרחב של הגורמים, המנגנונים, היקף הפגיעה והביטויים הופכים את ההגדרה הקלינית של הלם לבעייתית. כלומר דופק, לחץ דם ופעילות לבבית אינם מגדירים היטב הלם.

כדי להבין את הנושא נתחיל בפיזיולוגיה תאית, רקמתית והמודינמית תקינה. בהמשך יופיע פירוט המנגנונים הפתופיזיולוגיים. ההסבר הבא מתייחס להלם כמכלול.

חמצון הרקמות

רקמות הגוף זקוקות לחמצן כדי שתוכלנה לתפקד כראוי. החמצן נישא בדם על ידי ההמוגלובין. זרימת דם המתבצעת דרך הקפילות נקראת פרפוזיה. אם יש הפחתה באספקת הדם לרקמות הגוף, המצב נקרא היפו־פרפוזיה (היפו=חוסר). היפו־פרפוזיה מובילה לחוסר חמצן ברקמות, היפוקסיה.